

Diagnóstico visual - Café

Guía rápida de deficiencias nutricionales y errores de interpretación.

Café

Lectura rápida en campo

- Síntomas en hojas viejas orientan primero hacia nutrientes móviles; síntomas en hojas nuevas orientan primero hacia nutrientes poco móviles o inmóviles.
- Observe patrón, edad del tejido y distribución espacial antes de corregir.
- Cruce la lectura con pH, humedad, drenaje, historial y presión sanitaria.

Deficiencias - Café

Nutriente	Dónde inicia	Síntoma guía	Claves
N	Hojas viejas	Clorosis; en casos severos afecta zona productiva, con muerte descendente y paloteo.	Revisar alta carga y baja fertilización.
P	Hojas viejas	Amarillamiento desuniforme con manchas rojizas; posible defoliación.	Puede confundirse con envejecimiento/estrés estacional.
K	Hojas viejas	Necrosis en punta y bordes; defoliación en casos severos.	Especialmente relevante en producción.
Ca	Hojas nuevas	Clorosis en bordes de hojas nuevas.	Revisar acidez y saturación de aluminio.
Mg	Hojas viejas	Clorosis intervenal y defoliación en ramas productivas.	Puede coexistir con K alto.
S	Hojas nuevas	Clorosis uniforme de hojas más nuevas.	Se parece a N, pero inicia en tejido joven.
B	Brotes / hojas	Manchas café, muerte de yemas, rebrote lateral; "V" invertida y tejido corchoso.	Uno de los signos más distintivos del café.
Zn	Hojas nuevas	Hojas pequeñas, lanceoladas, cloróticas y entrenudos cortos.	No confundir con sequía o sombra intensa.
Mn	Hojas nuevas	Hojas grandes verde claro con nervaduras más oscuras.	Diferenciar de Fe por patrón de nervaduras.
Fe	Hojas nuevas	Hojas amarillas a verde pálido con nervaduras verdes.	Sospechar pH alto o limitación radicular.

Alcance

Esta pieza es un filtro de diagnóstico visual inicial. Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, salinidad, acidez, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño radicular/mecánico. Confirmar con análisis cuando sea posible.

Proveniencia y alcance

Base: Guía práctica para identificar deficiencias nutricionales - cinco cultivos. Se conserva su función diagnóstica y sus cautelas; no se convierte el síntoma visual en una prescripción cerrada.